

Sémiologie des Troubles Hydroelectrolytiques(2) : Les Œdèmes

**Pr H.Benabderrahmane
Service Médecine Interne
Unité Maladies métaboliques et Nutritionnelles
CHU Constantine
Faculté de Médecine, Université Constantine3**

PLAN

Introduction,Définition

Rappel physiologique

Sémiologie clinique

Raisonnement diagnostique

→Œdèmes des membres inferieurs de cause générale

→Œdèmes des membres inferieurs de cause locale

Selon programme national sémiologie 3eme Année Médecine

Année Universitaire 2024-2025

Sémiologie des Troubles Hydroelectrolytiques : Les Œdèmes

Introduction

Le syndrome œdémateux témoigne d'une hyperhydratation extracellulaire, avec rétention d'eau dans le secteur interstitiel.

Le transfert d'eau est dû à une anomalie du contenant (altération de la perméabilité capillaire), ou du contenu (variation des pressions hydrostatique et/ou oncotique).

Le syndrome œdémateux peut être la conséquence d'une pathologie locorégionale ou d'une pathologie systémique.

Après avoir éliminé les causes les plus fréquentes d'œdème généralisé ou localisé, une analyse sémiologique stricte permet le plus souvent d'orienter le diagnostic étiologique, qui conditionnera la prise en charge.

1-Définition:

L'œdème est défini comme l'accumulation visible ou palpable de fluide dans le tissu interstitiel.

Il est nécessaire de différencier :

-les œdèmes de cause locale, par inflammation, insuffisance veineuse ou lymphatique ;

-les œdèmes généralisés conséquence d'une positivité de la balance sodée et hydrique (hyperhydratation extracellulaire).

Dans les formes les plus graves, on parle **d'une anasarque** : c'est l'association d'œdèmes généralisés et d'épanchements des séreuses pleurales et/ou péritonéale (ascite) et/ou péricardique

2 -Rappel Physiopathologique :

L'œdème est la conséquence d'une augmentation du volume du secteur interstitiel qui peut être causé par plusieurs mécanismes :

- Une augmentation de la pression hydrostatique,
- Une diminution de la pression oncotique,
- Une augmentation de la perméabilité membranaire,
- Une altération du drainage lymphatique.

Ces mécanismes peuvent être associés.

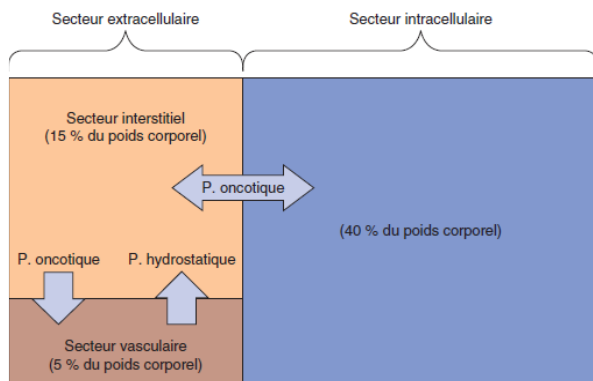


Fig1 Secteurs hydriques de l'organisme. P=pression

3-Sémiologie Clinique :

- La constitution d'un œdème provoque initialement une augmentation de volume du membre puis une atténuation et une disparition progressive des reliefs ostéo-musculaires et tendineux.
- Une mesure comparative de la circonférence du membre doit être objectivée lors de l'examen clinique à l'aide d'un mètre ruban
- La couleur, l'épaississement et la sensibilité de la peau de l'œdème aident au diagnostic :
 - Tension et chaleur sont évocatrices d'inflammation.
 - Une cyanose localisée peut témoigner d'un obstacle veineux.
- La palpation varie suivant l'ancienneté de l'œdème:
 - un œdème plus récent étant plus fréquemment élastique ou mou
 - un œdème ancien, plus fréquemment dur.

Le signe du godet est défini comme la persistance d'une dépression après appui digital sur la zone concernée

Devant un syndrome œdémateux, le clinicien passera par plusieurs étapes pour l'évaluer :

-L'**interrogatoire** : précisera les antécédents médicaux et chirurgicaux, les prises médicamenteuses, les allergies, le mode d'installation des œdèmes, et les signes associés.

-À l'**examen clinique**, l'œdème correspond à un infiltrat palpable du tissu sous-cutané.

Il faut en préciser :

- **l'aspect** : inflammatoire, blanc, induré. Pour les œdèmes des membres inférieurs, il faut préciser si ceux-ci prennent le godet ;
- **la localisation** : à préciser (au membre inférieur, membre supérieur, visage, etc.), ainsi que le caractère uni- ou bilatéral ; le caractère généralisé. Chez le sujet alité, il est nécessaire de chercher l'œdème au niveau des lombes. L'œdème généralisé doit également être recherché au niveau des séreuses (épanchement pleural, péricardique ou ascite) : Lorsque le syndrome œdémateux est diffus et atteint les séreuses, on parle d'anasarque ;
- **la périodicité**, ou caractère cyclique (lien avec les menstruations)
- **les facteurs favorisants** : alimentaires, médicament, etc. ;
- **les signes associés**: fièvre, prurit, éruption cutanée, altération de l'état général, etc.

-Enfin, il est nécessaire de recueillir **les éléments d'évaluation du secteur extracellulaire** : poids du patient, tension artérielle, fréquence cardiaque et diurèse des 24h ; Ces éléments permettront d'en suivre l'évolution.

4-Raisonnement diagnostique

Le premier temps diagnostique est de savoir si l'augmentation de volume est localisée ou généralisée, unilatérale ou bilatérale.

Si l'œdème est généralisé, il faut chercher tout d'abord l'existence d'une hypo-albuminémie significative (albuminémie <24 g/l)

L'anamnèse, l'examen clinique, l'analyse des urines et d'autres examens de laboratoire aideront le diagnostic.

4.1-L'œdème des membres inférieurs de cause générale

De caractère bilatéral et symétrique, il est volontiers retrouvé en déclivité. Sa localisation peut varier en fonction des positions adoptées par le patient, comme par exemple se situer à la face postérieure des cuisses et des lombes, si le patient est alité.

► Cette situation doit faire évoquer systématiquement cinq types de pathologies : cardiaque, rénale, hépatique, digestive et nutritionnelle :

1- Origine Cardiaque : Un œdème associé à un reflux hépato-jugulaire, une hépatomégalie, des hépatalgies, un signe de Harzer (signe de Harzer=perception de la pulsation du ventricule droit par la pulpe digitale sous la xyphoïde en inspiration profonde) de rattacher l'œdème à une **insuffisance cardiaque droite**
Le mécanisme : la pression veineuse systémique augmente, entraînant l'extravasation du liquide et un œdème

2-Origine Rénale : Une protéinurie importante (>3g/jour), une hypoalbuminémie sévère (<24g/l), une hypercholestérolémie sont la règle en cas de **syndrome néphrotique**. Pour le syndrome néphrotique, le mécanisme est une diminution de la pression oncotique induite par l'hypoalbuminémie par fuite rénale des protéines ; La rétention hydrosodée est à l'origine des œdèmes constatés dans les glomérulonéphrites et l'insuffisance rénale terminale oligurique.

3-Origine Hépatique : Une ascite, associée à des signes cliniques ou biologiques de **maladie hépatique** (exemple : cirrhose du foie) avec circulation veineuse collatérale abdominale, ictère, angiomes stellaires. Le mécanisme : hypertension portale seule ou associée à une insuffisance hépatique avec hypoalbuminémie

4 et 5-Origine Digestive et Nutritionnelle : Les **entéropathies exsudatives** seront suspectées devant un œdème associé à des signes de malabsorption ou une diarrhée chronique. Comme pour les **carences nutritionnelles** (dénutrition sévère type kwashiorkor) ;
Le mécanisme physiopathologique de l'œdème est l'hypoalbuminémie et la baisse de la pression oncotique

► Les autres causes pathologiques à souligner en deuxième intention :

-**Chez le patient âgé** : l'œdème est souvent multifactoriel intriquant parfois plusieurs atteintes.

-l'**œdème cyclique idiopathique de la femme**: très fréquent, il s'agit de la cause d'œdème des membres inférieurs la plus fréquente chez la femme en période d'activité génitale. Il survient surtout en phase prémenstruelle et dans un contexte psychologique d'anxiété. L'œdème est alors blanc, mou, prenant le godet, augmentant au cours de la journée et s'accompagne volontiers d'une prise de poids. Ses mécanismes physiopathologiques sont mal élucidés.

-Les **causes iatrogènes médicamenteuses** : Les médicaments qui présentent ce type d'effets indésirables sont nombreux :

Les oestro-progestatifs (contraception ou traitement hormonal substitutif), la testostérone,

les inhibiteurs calciques, les alpha-bloquants,

les corticoïdes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens,

l'insuline et les glitazones, les antidépresseurs inhibiteurs des MAO et tricycliques.

4.2- L'œdème des membres inférieurs de cause locale

Cette cause locale est représentée soit par les pathologies du système veineux ou du système lymphatique. Les signes cliniques sont souvent unilatéraux.

4.2.1- Les causes d'origine veineuse

► l'insuffisance veineuse superficielle chronique :

-étiologie très fréquente ; Le plus souvent primitive, elle peut évoluer ou non dans un contexte de maladie variqueuse et adopte fréquemment un caractère bilatéral.

-**Les signes associés** à l'œdème sont peu spécifiques prurit, sensation de brûlures, douleurs persistantes, et lourdeurs de jambe.

-**Un œdème d'origine veineuse sera évoqué devant le caractère intermittent,**

→favorisé par la position orthostatique prolongée, la chaleur et l'obésité ;

→ amélioré par la surélévation des membres, l'exercice physique, le froid et la compression élastique.

L'inspection et la palpation du membre inférieur retrouvent :

un œdème initialement blanc, mou, prenant le godet, sans redistribution vers d'autres territoires.

Il s'y associe souvent d'autres signes de stase comme l'apparition de varicosités de la cheville et de l'arche plantaire interne ou des télangiectasies malléolaires.

Des signes cutanés signant le retentissement tissulaire peuvent être présents : la dermite ocre, « atrophie blanche de Milian », eczéma variqueux, une hypodermite scléreuse (ou lipodermatosclérose) voire même un ulcère ou ses séquelles.

► Le syndrome post-thrombotique :

deuxième cause en ordre de fréquence d'œdème chronique d'origine veineuse,

- Il est provoqué par une altération du système valvulaire des veines profondes et des perforantes, secondaire à une thrombose veineuse.

-Il en résulte une hyperpression veineuse qui est à l'origine de l'œdème, de l'hypoxie tissulaire pouvant faire le lit des ulcères cutanés.

-Le diagnostic est essentiellement clinique

-L'interrogatoire recherche des antécédents de thrombose veineuse profonde avec des facteurs prédictifs de survenue d'un syndrome post-thrombotique :

-des thromboses veineuses répétées ipsilatérales,

-une mauvaise qualité du traitement anticoagulant,

-l'absence de contention veineuse.

-Le diagnostic peut être confirmé par la présence de signes d'incompétence valvulaire à l'écho-doppler veineux des membres inférieurs.

► Une **compression veineuse extrinsèque**, tels qu'une adénopathie, une tumeur ou un anévrisme comprimant une veine, peut aussi être la cause d'un œdème persistant des membres inférieurs.

Un examen clinique attentif et une échographie vasculaire permettent facilement de confirmer cette hypothèse.

4.2.2 Œdème de cause lymphatique

Un déficit du drainage lymphatique par dysfonctionnement des vaisseaux lymphatiques provoque un œdème particulier qui est défini comme lymphoedème.

Le diagnostic de lymphoedème est clinique et doit toujours être évoqué devant :

- la présence d'un œdème non douloureux d'installation progressive ayant la particularité de marquer franchement les plis articulaires des pieds
- et d'être associé à une impossibilité de plisser la peau de la face dorsale de la première phalange du deuxième orteil : c'est le signe de Stemmer.

Le lymphoedème débute à consistance élastique, puis, devenant fibrineux, il prend une consistance dure. Il a été classé en stades :

Stades évolutifs du lymphoedème (**International Lymphoedema Society**) :

- stade I : œdème modéré et fluctuant, régressif avec la surélévation du membre au repos. Il existe un signe du godet.
- stade II : œdème permanent avec signe de Stemmer ; le signe du godet disparaît tandis que la fibrose augmente.
- stade III : éléphantiasis avec œdèmes déformants et modifications cutanées majeures : accentuation des plis cutanés, hyperkératose et papillomatose cutanée

-Le caractère bilatéral oriente plutôt vers un lymphoedème primitif qui peut être présent dès la naissance ou révélé à l'occasion d'un traumatisme parfois minime chez l'adulte jeune. Le caractère unilatéral doit faire évoquer une forme secondaire par destruction ou compression du réseau lymphatique.

-L'interrogatoire recherche des antécédents de chirurgie et de radiothérapie pelvienne, voire une cause parasitaire suite à un voyage en zone d'endémie filaire (filariose)

-L'examen clinique recherchera des adénopathies inguinales et crurales, parfois révélatrice d'un lymphome. Les touchers pelviens permettent de rechercher une masse tumorale.

.

Références :

- M Roriz et al . Oedemes .EMC Traité de Médecine Akos 2019;14(3):1-5 [1-0830].
- Semiologie Vasculaire Collège National des Enseignants de Médecine Vasculaire
- Syndromes œdémateux Manuel Cuen 2018